DOR TORÁCICA NA EMERGÊNCIA: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Resumo da aula · Prof. Wilton F. Gomes · Medicina 8º período · 2026

FACULDADES pequenoPRÍNCIPE

1 É INFARTO? ECG EM 10 MIN + TROPONINA ULTRASSENSÍVEL 0/1 H

Supra de ST ou instabilidade pulam a estratificação. Sem supra e estável: dosar hs-cTn na chegada e em 1 h (ou 0/2 h). Referência (percentil 99) da **Elecsys hs-cTnT: até 14 ng/L**. Cortes abaixo para esse ensaio, em ng/L — cada ensaio tem os seus.

RULE-OUT
0 h < 5 e dor > 3 h, ou **0 h < 12** e **Δ1h < 3** → IAM descartado; aplicar o HEART.

OBSERVAÇÃO
Nenhum dos critérios → 3ª dosagem em 3 h + ecocardiograma; reavaliar.

RULE-IN
0 h ≥ 52 ou **Δ1h ≥ 5** → IAMSSST: internar, estratificar, cateterismo.

2 PODE IR PARA CASA? HEART

	0	1	2
História	pouco suspeita	moderada	muito suspeita
ECG	normal	repol. inespecífica	desvio de ST
Idade	< 45	45–64	≥ 65
Risco	nenhum	1–2 fatores	≥ 3 ou DAC
Troponina	≤ referência (≤ 14 ng/L)	1–3× (15–42)	> 3× (> 42)

MACE 6 semanas: **0–3: 1,7%** · 4–6: 16,6% · 7–10: 50,1%.
HEART ≤ 3 + rule-out → alta com reavaliação ambulatorial. HEART ≥ 4 → estratificação não invasiva. Não usar se história muito suspeita, troponina em curva, ECG isquêmico ou instabilidade.

3 QUÃO GRAVE? KILLIP

I	sem congestão	6%
II	estertores em bases, B3, turgência jugular	17%
III	edema agudo de pulmão	38%
IV	choque cardiogênico	81%

Mortalidade hospitalar na série original (1967). Killip ≥ II contraindica betabloqueador agudo.

4 RISCO DE EVENTOS E DE SANGRAMENTO

TIMI (1 ponto cada): idade ≥ 65 · ≥ 3 FR · DAC conhecida · AAS 7 d · ≥ 2 anginas/24 h · ST ≥ 0,5 mm · marcador ↑. 0–2 baixo · 3–4 intermediário · ≥ 5 alto (6–7: 40,9% em 14 d).
GRACE (calculadora): ≤ 108 baixo · 109–140 intermediário · **> 140 alto**.
Sangramento: CRUSADE; ARC-HBR (≥ 75 anos, anticoagulação, DRC grave, anemia, plaquetopenia, sangramento/AVC prévio, câncer). Acesso radial.

5 CATETERISMO: QUEM E QUANDO (ESC 2023)

< 2 h
instabilidade/choque, dor refratária, arritmia grave/PCR, complicação mecânica, IC aguda, ST dinâmico recorrente

< 24 h
IAMSSST (rule-in), ST/T dinâmico, supra transitório, **GRACE > 140**

Seletiva
sem alto risco e baixa suspeita: teste não invasivo antes

A SBC 2021 ainda prevê < 72 h para risco intermediário. Quanto maior o risco, maior o benefício da invasiva (Fox 2010).

MEDIDAS INICIAIS — O QUE MUDOU

- **O_2** só se $SatO_2$ < 90%.
- **Morfina** não de rotina (atrasa P2Y12 oral). Nitrato para dor, se PAS ≥ 90 e sem IAM de VD/PDE-5.
- **AAS** ataque + manutenção · **anticoagulação** (enoxaparina ou fondaparinux).
- **P2Y12**: sem pré-tratamento rotineiro se cateterismo < 24 h.
- **Betabloqueador** oral só sem IC/Killip ≥ II, baixo débito ou BAV · **estatina** alta intensidade.

BAIXO RISCO: QUAL EXAME?

Angio-TC de coronárias: sensibilidade ~97%, ótimo VPN — exclui DAC obstrutiva. **Funcionais com imagem** (eco de estresse, cintilografia, RM de estresse): localizam e quantificam isquemia. **Ergométrico**: sens. ~58%, espec. ~62%; não interpretável com BRE, pré-excitação, marca-passo ou ST basal alterado (Knuuti 2018).

Abreviações: IAM, infarto agudo do miocárdio; IAMSSST, infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST; ECG, eletrocardiograma; hs-cTn, troponina cardíaca ultrassensível; hs-cTnT, troponina T cardíaca ultrassensível; Δ1h, variação da troponina entre 0 h e 1 h; B3, terceira bulha cardíaca; BRE, bloqueio de ramo esquerdo; BAV, bloqueio atrioventricular; PCR, parada cardiorrespiratória; PAS, pressão arterial sistólica; $SatO_2$, saturação periférica de oxigênio; O_2, oxigênio; IC, insuficiência cardíaca; VD, ventrículo direito; DAC, doença arterial coronariana; FR, fatores de risco cardiovascular; DRC, doença renal crônica; AAS, ácido acetilsalicílico; P2Y12, inibidor do receptor plaquetário P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel); PDE-5, fosfodiesterase 5 (inibidores: sildenafila, tadalafila); AVC, acidente vascular cerebral; MACE, eventos cardiovasculares adversos maiores; VPN, valor preditivo negativo; RM, ressonância magnética cardíaca; HEART, History, ECG, Age, Risk factors, Troponin (história, ECG, idade, fatores de risco, troponina); TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infarction (escore de risco); GRACE, Global Registry of Acute Coronary Events (escore de risco); CRUSADE, escore de risco de sangramento do registro CRUSADE; ARC-HBR, Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (critérios de alto risco de sangramento); ESC, Sociedade Europeia de Cardiologia; SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Byrne RA et al. ESC 2023 (Eur Heart J 2023;44:3720) · Rao SV et al. ACC/AHA 2025 (Circulation 2025;151:e771) · Diretriz SBC Dor Torácica 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250620) · Nicolau JC et al. SBC AI/IAMSSST 2021 · Six 2008 / Backus 2013 (HEART) · Antman 2000 (TIMI) · Granger 2003 (GRACE) · Killip 1967 · Subherwal 2009 · Urban 2019 · Fox 2010 · Knuuti 2018.

willfgo.github.io/aulas-fpp/risco-sca